每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-10-03 ~ 2026-10-09

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM｜Lancet｜EHJ｜JACC 系列｜Circulation 系列｜EuroIntervention

📱 每篇 Top Pick / 分欄文獻附 QR Code，可掃描跳轉原文

🎯 本週主題與固定欄目

介入與裝置治療的實證週

本週六大固定欄目：

1. ⭐ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選（PE 介入／易損斑塊／節律／HBR 球囊／AI 穿戴）
2. 🫀 **TAVI Section** — 傳導障礙處置 × 新瓣膜登錄 × PCI 時機
3. 🔧 **TEER Section** — TRI-FR 血流動力學 × PADN × AFR 救援
4. 📚 **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5. 🔬 **Case Reports** — 結構／冠脈介入／EP × 5
6. 📖 **參考文獻 + 縮寫對照**

⭐ Top 5 Picks

#	試驗／研究	期刊	關鍵數字
1	**STORM-PE**	*JACC Cardiovasc Interv*	RV/LV 下降 **0.52 vs 0.24**（p<0.001）
2	**PREVENT 子分析**	*Circulation*	LRP 預防性 PCI aHR **0.23**；非 LRP 無益
3	**CONDUCT-AF**	*Eur Heart J*	CSP vs BVP：LVEF 差 **0.4%**（p=0.002 NI）
4	**SELUTION DeNovo HBR**	*EuroIntervention*	TVF 4.9% vs 7.9%（➰ 未達檢定力）
5	**LINK-HF2**	*JACC Heart Fail*	HF 再住院 HR **0.90**（p=0.76，❌ 中性）

Pick #1

STORM-PE

中高風險肺栓塞的機械取栓 RCT

STORM-PE — 設計

Rosovsky R, Konstantinides S, Weinberg I, et al. *JACC Cardiovasc Interv* 2026.

🔗 DOI: 10.1016/j.jcin.2026.07.042

- 前瞻、多中心、隨機對照試驗 (RCT)，**22 中心，n = 100**
- 對象：中高風險急性肺栓塞 (Pulmonary Embolism, PE)
- 分組：**電腦輔助真空機械取栓 (CAVT) + 抗凝（n=47）vs 單純抗凝（n=53）**
- 主要終點：**48 小時右心室／左心室 (RV/LV) 比值變化**（影像 surrogate）

Scan DOI

0.52 vs 0.24

48h RV/LV 比值下降 — CAVT vs 單純抗凝

差異 0.27 | p < 0.001

7 天重大不良事件 **4.3% vs 7.5%**（安全性相當，NS）

並改善 **90 天功能與生活品質**

STORM-PE — 臨床啟示

✅ 中高風險 PE 機械取栓第一次有了**隨機 + 功能終點**的證據

- 右心受壓的中高風險 PE，**CAVT 是可考慮的早期減壓選項**
- 適合右心儲備差、擔心後續惡化者 → PERT 團隊討論

⚠️ 主要終點為 **48h RV/LV surrogate**（非死亡率，n=100），廠商 (Penumbra) 支持；硬終點待更大型試驗

Pick #2

PREVENT 子分析

預防性 PCI 要「看斑塊成分」

PREVENT 子分析 — 設計

Wee Y, Ahn JM, Kang DY, et al. *Circulation* 2026.

🔗 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.126.080384

- PREVENT 試驗（FFR>0.80 易損斑塊預防性 PCI vs OMT）事後分析
- n = **598 人／632 病灶**（IVUS 斑塊負荷>70%、最小管腔<4 mm²，加做 NIRS）
- 脂質豐富斑塊 (LRP)：4-mm 最大脂質核心負荷指數 **$\text{maxLCBI}_{4\text{mm}} > 315$**

📱 Scan DOI

PREVENT 子分析 — 結果

族群	預防性 PCI vs OMT	校正 HR
LRP（脂質豐富）	7.3% vs 17.6%	**0.23（0.13–0.41）**
非 LRP	5.5% vs 4.2%	1.00（0.54–1.86）

治療 × LRP **交互作用 p < 0.001**（中位追蹤 5.6 年）

> **形態同樣「嚴重」，只有 NIRS 脂質豐富者從預防性 PCI 獲益** — 成分比狹窄嚴重度更關鍵

PREVENT 子分析 — 臨床啟示

> FFR 陰性、IVUS 看來嚇人的非阻塞斑塊：
> **先問「它是不是脂質豐富 (LRP)」**

- 有 NIRS / OCT 佐證的高脂質核心 → 預防性 PCI 才站得住腳
- 否則以**強效降脂等 OMT** 為主，避免 oculostenotic reflex 式過度支架

➰ 務實界限：事後分析、NIRS 僅部分病灶、需前瞻驗證

Pick #3

CONDUCT-AF

房室結燒灼後：CSP vs BVP

CONDUCT-AF — 設計與結果

Žižek D, Ivanovski M, Mrak M, et al. *Eur Heart J* 2026.

🔗 DOI: 10.1093/eurheartj/ehag699

- 多中心 RCT，n=82；難治性心房顫動 (AF) + 心衰、窄 QRS，接受房室結燒灼
- **傳導系統節律 (CSP / 左束支區) vs 雙心室節律 (BVP)**

終點	數值
6 個月 LVEF	CSP 36→46%｜BVP 34→46%
組間差	**0.4%（−3.1~3.8），p=0.002 for NI**
CSP 優勢	paced QRS −14 ms、程序／透視時間更短

Scan DOI

CONDUCT-AF — 臨床啟示

> ✅ 「ablate-and-pace」病人：**CSP 非劣於 BVP**，且更簡、QRS 更生理

- 房室結燒灼後的生理性節律（左束支區）是 BVP 的合理替代
- 尤其 BVP 置放困難或希望縮短手術者

➰ 務實界限：n=82、主要終點為影像 LVEF、追蹤僅 6 個月

Pick #4

SELUTION DeNovo HBR

高出血風險 PCI 的藥物球囊

SELUTION DeNovo HBR — 設計與結果

Rissanen TT, Eccleshall S, Krackhardt F, et al. *EuroIntervention* 2026;22(19):e1025-e1035.

🔗 DOI: 10.4244/EIJ-D-26-00889

- SELUTION DeNovo（n=3,323）之預設高出血風險 (HBR) 子分析；HBR **n=522**
- **sirolimus 藥物球囊 (SEB) + 必要時支架 vs 系統性 DES**

1 年終點	SEB vs DES
標的血管失敗 (TVF)	4.9% vs 7.9%
大出血 (BARC 3-5)	2.3% vs 3.2%
NACE	6.8% vs 10.7%
6 個月停所有抗血小板	**27.8% vs 14.9%（p<0.001）**

Scan DOI

SELUTION DeNovo HBR — 臨床啟示

> ➰ SEB 策略數值有利、能更早停抗血小板，但**未達檢定力、非優越**

- HBR PCI 的工具箱可納入**藥物球囊（少放支架、縮短 DAPT）**
- 須接受約 **17% 需 bailout 支架**
- ❌ 不能據此宣稱 SEB 優於 DES — 待專為 HBR 設計的大型試驗

Pick #5

LINK-HF2

AI 穿戴偵測 ≠ 改善結果（負向教材）

LINK-HF2 — 設計與結果

Sideris K, Schmalfuss C, Lewis EF, et al. *JACC Heart Fail* 2026.

🔗 DOI: 10.1016/j.jchf.2026.103422

- 隨機、開放標籤、盲性終點；5 個 VA 中心；急性心衰出院後戴連續貼片至 90 天
- n=171（AI 導引監測 + 臨床通報 80｜標準照護 91）

終點	數值
HF 再住院	16.3% vs 18.7%（**HR 0.90，0.43–1.84，p=0.76**）
複合（住院／急診／死亡）	HR 1.03（p=0.89，NS）
AI 偵測生理不穩定	**HR 0.76（0.60–0.97，p=0.025）**

Scan DOI

LINK-HF2 — 臨床啟示

> ❌ AI 偵測**準**（不穩定 HR 0.76），但**未改善臨床事件** — 偵測準 ≠ 結果好

- 導入穿戴／遠距監測前，要先設計好**「偵測到異常後怎麼做」的結構化反應路徑**
- 否則只增加警訊疲勞
- 務實界限：可行性研究、n=171、臨床終點為探索性（勿解讀為「遠距監測無效」）



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

傳導障礙處置 × 新瓣膜 × PCI 時機

TAVI #1 — GLAM-TAVI：傳導障礙處置

Novelli L, Occhipinti G, Laudani C, et al. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)* 2026.

🔗 DOI: 10.1016/j.rec.2026.10.001

- 歐美 6 中心登錄；TAVI 後傳導障礙 (CD) 345 例（個體化觀望 160 / 標準指引 185）

1 年終點	個體化 vs 標準
主要複合（死亡/再住院）	13.6% vs 7.1%（aHR 1.23，NS）
永久節律器 (PPM)	**49.4% vs 80.2%（aHR 0.61）**
心血管死亡	**8.4% vs 1.2%（aHR 9.10）**

⚠️ pacemaker-sparing 少裝節律器，**但可能以較高心血管死亡為代價**

Scan DOI

TAVI #2 — Octapro MyPro 登錄

Ielasi A, Moscarella E, Verček G, et al. *Int J Cardiol* 2026;465:134967.

🔗 DOI: 10.1016/j.ijcard.2026.134967

- 新一代球擴瓣 Octapro 真實世界登錄，n=303（歐洲+印度）
- VARC-3 技術成功 **97%**、程序死亡 0.3%、30 天 PPM **14.2%**、中重度瓣旁漏 3.3%
- **PPM 獨立預測因子：植入深度（閾值 4.75 mm） + 基礎右束支傳導阻滯 (RBBB)**

> 💡 與其事後糾結要不要裝節律器，不如**術中就把植入深度做淺**；對基礎 RBBB 者更嚴控

📱 Scan DOI

TAVI #3 — ASCoP：TAVI + 高風險 PCI 時機

Munafò AR, Esposito G, Khokhar A, et al. *Int J Cardiol* 2026.

🔗 DOI: 10.1016/j.ijcard.2026.134968

- 多中心登錄，n=519；依 PCI 時機分三組（同時 30.1% / TAVI 前 64.1% / TAVI 後 5.8%）

策略	1 年結果
TAVI 後才分階段 PCI	主要複合終點**較差**（HR **2.31**，1.24–4.32）
TAVI 前先 PCI	MACCE **較低**（HR 0.55，0.35–0.85）

> 💡 傾向 **TAVI 前或同時**完成高風險血運重建；務實界限：觀察性、TAVI 後組僅 n=30

📱 Scan DOI

🔧 TEER Section

二尖瓣／三尖瓣緣對緣與瓣膜介入

Drake 的 TEER 操作面向

TEER #1 — TRI-FR 血流動力學子分析

Donal E, Leurent G, Zygouri A, et al. *Heart* 2026.

🔗 DOI: 10.1136/heartjnl-2026-328062

- TRI-FR 隨機試驗（經導管三尖瓣緣對緣修復 T-TEER + 藥物 vs 單純藥物）之**探索性子分析**
- 聚焦**基礎侵入性右心血流動力學**（右房壓、肺動脈壓、後負荷）與治療反應的關係

> 💡 T-TEER 成敗取決於**右心儲備與後負荷** — 術前右心導管有助於精準化病人選擇與時機
> 不可逆右心衰竭／重度肺高壓者效益有限

📱 Scan DOI

TEER #2 — PADN 治療 M-TEER 後持續肺高壓

Chen X, Zhang Z, Lan X, et al. *Pulm Circ* 2026;16(4):e70404.
🔗 DOI: 10.1002/pul2.70404

- 試驗性研究，n=6；成功 M-TEER 後仍持續 WHO Group 2 肺高壓者接受**肺動脈去神經術 (PADN)**

終點	數值
術後立即平均肺動脈壓 (mPAP)	38.5 → 34.0 mmHg（p=0.028）
6 分鐘步行距離	377 → 436 m（p=0.046）
三尖瓣逆流改善	5/6（83%）

💡 M-TEER「殘餘肺高壓」是未滿足缺口；PADN 可行、安全、短期有改善訊號（n=6、數 6 月未達顯著）

📱 Scan DOI

TEER #3 — AFR 救援：M-TEER 後左房僵硬致反覆肺水腫

Sooknanan NN, Fernandez-Hazim CM, Tuluca A, et al. *JACC Case Rep* 2026:110447.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110447

- 70 歲女性，M-TEER 後僅殘餘輕度 MR 卻反覆肺水腫
- 血流動力學：左房壓升高、**高大 V 波** → 左房順應性下降（stiff LA／左房高壓 LAH）
- 植入**心房血流調節器 (AFR)** 持久左至右分流，12 個月無再住院

> 💡 M-TEER 後反覆肺水腫但 MR 不重 → 想到**左房僵硬／LAH**；AFR 可作左房減壓救援

📱 Scan DOI

📚 Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀（1/2）

研究	期刊	重點	連結
DanGer Shock SYNTAX 子分析	*EuroIntervention*	高基礎 SYNTAX → 180 天死亡 aOR **3.12**；孤立左主幹亞組 Impella aOR 0.17（假說生成）	DOI
Multivessel TALENT 子分析	*EuroIntervention*	標準化器械成功（核心 QCA 88.0%）< 操作者目視（97.4%）；未達者 1 年事件更高	DOI
DEEP-PFA RCT	*Circ Arrhythm EP*	EP 醫師主導深度鎮靜下，雙極接觸力導管行 AF 脈衝場消融 (PFA)	DOI

其他值得一讀（2/2）

研究	期刊	重點	連結
過度小樑化 CMR 風險分數	*JACC Cardiovasc Imaging*	589 人／17 中心；以不良重塑與纖維化建立 CMR 風險分數預測 MACE	DOI
ACHD 後天性風險因子	*Eur Heart J*	9,826 人；吸菸 HR 1.67、睡眠呼吸中止 2.22、冠心病 1.78 皆獨立增死亡	DOI
中國院內心跳停止登錄	*Circulation*	BASIC-IHCA、37 院；中低收入國家首批多中心 IHCA 基準數據	DOI



Case Reports

結構 × 冠脈介入 × EP

本週 5 例

Case #1 — TAVR 遇上突出的 RCA 支架

Iyengar A, Wong A, Muuse J, et al. *JACC Case Rep* 2026:110627.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110627

81 歲女性重度 AS，右冠狀動脈 (RCA) 開口支架 10 mm 段突入主動脈根部。

四步可重現流程：

1. 導絲穿支架網眼 → **創造 neo-ostium**
2. 瓣膜成形球囊 **crush（壓貼主動脈壁）**
3. 控制性球擴瓣部署
4. 開口優化 → 無冠脈阻塞

Scan DOI

Case #2 — 腋動脈 Impella 5.5 橋接 CIED 心內膜炎

Tamura Y, Nakahara S, Saito M, et al. *J Artif Organs* 2026;29(4).

🔗 DOI: 10.1007/s10047-026-01599-y

53 歲擴張型心肌病、CRT-D 感染（MSSA、休克、LVEF 10%）；17 年舊除顫導線拔除極高風險。

- 先經鎖骨下動脈植入 **Impella 5.5** + 外科引流囊袋（感染源控制）
- 穩定後第 6 天在支持下**完整拔線**，最終橋接至 **永久左心室輔助裝置 (LVAD)**

> 💡 腋動脈 Impella 5.5 = 分階段源控制、高風險拔線、器官恢復與橋接的穩定平台

📱 Scan DOI

Case #3 — 「刻意分盤手法」輔助 ASD 封堵器判讀

Ohashi H, Mitani Y, Harada T, et al. *JACC Case Rep* 2026:110640.

🔗 DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.110640

3 例複雜心房中隔缺損 (ASD)（邊緣不足、鬆軟中隔、中隔瘤），GORE CARDIOFORM 封堵。

- 鎖定前輕拉滑桿、在兩盤間製造暫時間隙（**intentional disc separation**）
- 以 TEE + 透視互補確認花瓣方向與中隔貼合 → 安全部署、無殘餘分流

> 💡 嚴格定位為**影像輔助、非機械穩定測試**；困難解剖提升判讀信心

📱 Scan DOI

Case #4 — 斑塊內出血：被低估的冠脈不穩定機轉

Duband B, Souteyrand G, Motreff P. *Ann Cardiol Angeiol (Paris)* 2026:102087.

🔗 DOI: 10.1016/j.ancard.2026.102087

49 歲女性 LAD 血栓性阻塞引發急性冠心症 (ACS)，抽吸+抗栓、未置放支架。

- 1 個月光學同調斷層 (OCT)：**癒合的斑塊糜爛**、無顯著殘餘狹窄
- 5 個月後復發 → OCT 見**斑塊內出血 (intraplaque hemorrhage)**，快速進展為重度狹窄

> 💡 表面「癒合」的斑塊仍可能脆弱；defer stenting 策略須警覺短期快速進展並追蹤

Scan DOI

Case #5 — 難治 LV summit VT：多能量序貫消融

Bhagirath P, Regany M, Pierucci N, et al. *Heart Rhythm* 2026.

🔗 DOI: 10.1016/j.hrthm.2026.09.055

難治性左心室頂部 (LV summit) 心室頻脈 (VT)，依序以三種能量消融：

單極射頻 (RF) → 局部脈衝場消融 (PFA) → 雙極 RF

- 以心臟磁振造影 (CMR) 呈現各能量在心肌的**消融足跡／病灶範圍**

> 💡 單一能量無效時，多能量序貫是進階選項；CMR 可視化不同能量的深度與範圍

📱 Scan DOI

💎 Take Home Message

1. STORM-PE ✅ 中高風險 PE 機械取栓有隨機證據（RV/LV ↓ 0.52 vs 0.24；surrogate 終點）

2. PREVENT 子分析 ✅ 預防性 PCI 看成分 — 只有 NIRS 脂質豐富者獲益（aHR 0.23）

3. CONDUCT-AF ✅ 房室結燒灼後 CSP 非劣於 BVP，程序更簡、QRS 更生理

4. SELUTION HBR ➰ / LINK-HF2 ❌ 藥物球囊未達檢定力；AI 偵測準 ≠ 改善結果

5. TAVI 傳導障礙 🫀 淺植入 > 事後觀望（GLAM 觀望少 PPM 但心血管死亡偏高；Octapro 閾值 4.75 mm + RBBB）

6. TAVI + 高風險 PCI（ASCOP）「TAVI 後才補 PCI」1 年最差（HR 2.31）

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Rosovsky R, et al. STORM-PE. *JACC Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42836810
2. Wee Y, Ahn JM, et al. PREVENT 子分析（NIRS 脂質負荷）. *Circulation* 2026. PMID 42836296
3. Žižek D, et al. CONDUCT-AF. *Eur Heart J* 2026. PMID 42834810
4. Rissanen TT, et al. SELUTION DeNovo HBR substudy. *EuroIntervention* 2026;22(19):e1025-e1035. PMID 42837205
5. Sideris K, et al. LINK-HF2. *JACC Heart Fail* 2026. PMID 42853165

TAVI Section

6. Novelli L, et al. GLAM-TAVI. *Rev Esp Cardiol* 2026. PMID 42843586
7. Ielasi A, et al. Octapro MyPro registry. *Int J Cardiol* 2026;465:134967. PMID 42838146
8. Munafò AR, et al. ASCoP registry. *Int J Cardiol* 2026. PMID 42838145

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section

9. Donal E, et al. TRI-FR haemodynamics. *Heart* 2026. PMID 42850060
10. Chen X, et al. PADN post-M-TEER. *Pulm Circ* 2026;16(4):e70404. PMID 42840917
11. Sooknanan NN, et al. AFR for LAH post-M-TEER. *JACC Case Rep* 2026:110447. PMID 42848362

Honorable Mentions

12. Marquard JM, et al. DanGer Shock SYNTAX substudy. *EuroIntervention* 2026;22(19):e1036-e1047. PMID 42837204
13. Oshima A, et al. Multivessel TALENT device success. *EuroIntervention* 2026;22(19):e1048-e1063. PMID 42837202
14. Li X, et al. DEEP-PFA. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2026. PMID 42845271
15. Casas G, et al. Excessive trabeculation CMR risk score. *JACC Cardiovasc Imaging* 2026. PMID 42841847
16. Umei M, et al. ACHD acquired risk factors. *Eur Heart J* 2026. PMID 42834856
17. Wang C, et al. IHCA in China registry. *Circulation* 2026. PMID 42836281

Case Reports

18. Iyengar A, et al. *JACC Case Rep* 2026:110627. PMID 42841825 | 19. Tamura Y, et al. *J Artif Organs* 2026. PMID 42853285 | 20. Ohashi H, et al. *JACC Case Rep* 2026:110640. PMID 42848359 | 21. Duband B, et al. *Ann Cardiol Angeiol* 2026:102087. PMID 42844064 | 22. Bhagirath P, et al. *Heart Rhythm* 2026. PMID 42849683

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
PE	Pulmonary Embolism	肺栓塞
RV / LV	Right / Left Ventricle	右／左心室
CAVT	Computer-Assisted Vacuum Thrombectomy	電腦輔助真空機械取栓
PERT	Pulmonary Embolism Response Team	肺栓塞反應團隊
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入
FFR	Fractional Flow Reserve	血流儲備分數
IVUS / OCT	Intravascular Ultrasound / Optical Coherence Tomography	血管內超音波／光學同調斷層
NIRS	Near-Infrared Spectroscopy	近紅外光譜
LCBI	Lipid Core Burden Index	脂質核心負荷指數
LRP	Lipid-Rich Plaque	脂質豐富斑塊
OMT	Optimal Medical Therapy	最佳藥物治療
DES / SEB	Drug-Eluting Stent / Sirolimus-Eluting Balloon	藥物釋放支架／希羅莫斯藥物球囊
HBR / DAPT	High Bleeding Risk / Dual Antiplatelet Therapy	高出血風險／雙重抗血小板治療
TVF / NACE	Target Vessel Failure / Net Adverse Clinical Events	標的血管失敗／淨臨床不良事件
AF	Atrial Fibrillation	心房顫動
CSP / BVP	Conduction System / Biventricular Pacing	傳導系統節律／雙心室節律
PFA / VT / RF	Pulsed Field Ablation / Ventricular Tachycardia / Radiofrequency	脈衝場消融／心室頻脈／射頻
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射血分數
HR / aHR / aOR	(adjusted) Hazard / Odds Ratio	（校正）風險比／勝算比
NI / NS	Non-Inferiority / Not Significant	非劣性／未達顯著

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation / Replacement	經導管主動脈瓣植入／置換
AS	Aortic Stenosis	主動脈瓣狹窄
PPM	Permanent Pacemaker	永久性節律器
RBBB / LBBB	Right / Left Bundle Branch Block	右／左束支傳導阻滯
CD	Conduction Disturbance	傳導障礙
VARC-3	Valve Academic Research Consortium-3	瓣膜學術研究聯盟第 3 版
TEER / M-TEER / T-TEER	(Mitral/Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	（二尖／三尖瓣）經導管緣對緣修復
MR / TR	Mitral / Tricuspid Regurgitation	二尖瓣／三尖瓣逆流
PADN	Pulmonary Artery Denervation	肺動脈去神經術
PH / mPAP	Pulmonary Hypertension / mean Pulmonary Artery Pressure	肺高壓／平均肺動脈壓
LAH / AFR	Left Atrial Hypertension / Atrial Flow Regulator	左心房高壓／心房血流調節器
ASD / PFO	Atrial Septal Defect / Patent Foramen Ovale	心房中隔缺損／開放性卵圓孔
TEE / CMR / LGE	Transesophageal Echo / Cardiac MR / Late Gadolinium Enhancement	經食道超音波／心臟磁振造影／晚期釓增強
ACS / NSTEMI	Acute Coronary Syndrome / Non–ST-Elevation MI	急性冠心症／非 ST 上升心梗
RCA / LAD	Right Coronary Artery / Left Anterior Descending	右冠狀動脈／左前降支
CIED / IE / MSSA	Cardiac Implantable Electronic Device / Infective Endocarditis / Methicillin-Sensitive S. aureus	心臟植入式電子裝置／感染性心內膜炎／甲氧西林敏感金黃葡萄球菌
MCS / LVAD	Mechanical Circulatory Support / Left Ventricular Assist Device	機械循環支持／左心室輔助裝置
ACHD / IHCA	Adult Congenital Heart Disease / In-Hospital Cardiac Arrest	成人先天性心臟病／院內心跳停止
SYNTAX	Synergy Between PCI with Taxus and Cardiac Surgery score	冠脈病變複雜度評分

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC
心臟內科｜結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。